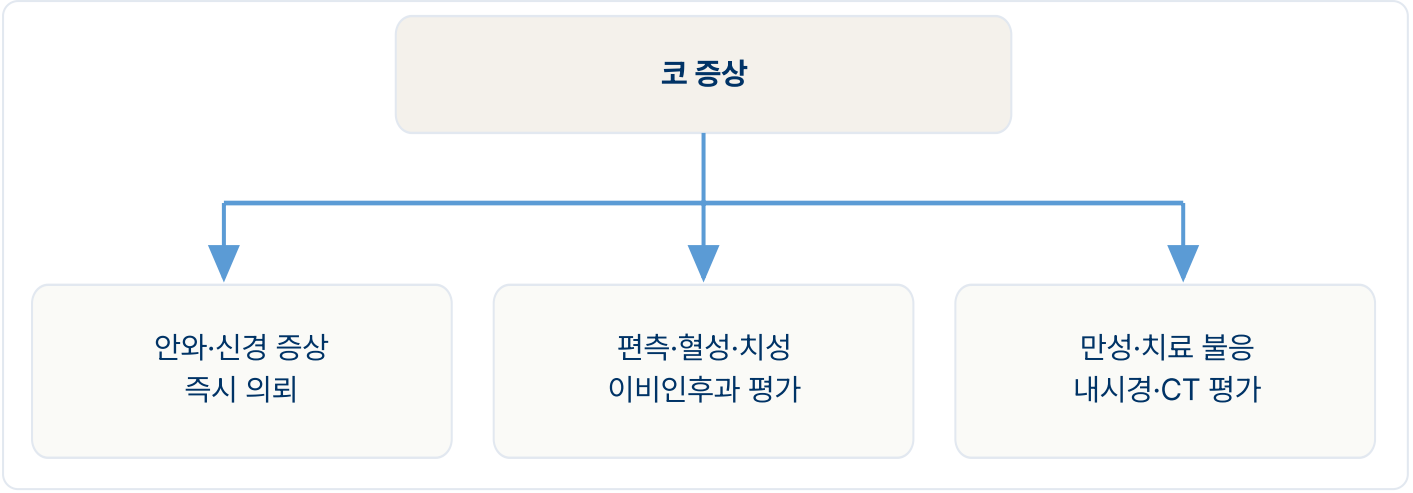
코·부비동 증상 응급과 일반 의뢰를 가르는 신호

기간·편측성·안와 및 신경 증상부터 확인



즉시 의뢰

안와 부종·복시·시력저하, 심한 두통·의식변화·고열·경부강직은 즉시 의뢰합니다. 면역저하 환자도 신속히 의뢰합니다.

! 신속한 이비인후과 평가

편측 코막힘·혈성 분비물·편측 단일 폴립은 종양을 감별합니다. 치과 치료 뒤 편측 악취성 분비물이나 위 어금니 통증은 치성 원인을 생각합니다.

만성 증상·치료 불응

≥12주, 주증상 ≥2개와 내시경/CT 객관 소견으로 CRS를 진단합니다. INCS+세척 ≥8주에도 조절되지 않거나 폴립·후각소실이 있으면 수술·생물학적제제 평가를 의뢰합니다.

의뢰 전 정리할 소견

검사·구조·우연한 낭종을 구분

문진 4축

증상(맑은/누런 콧물·코막힘·안면통·후각), 기간(며칠·10일·12주), 패턴(계절·유발인자·편측), 경과(호전 뒤 재악화)를 기록합니다. 급성 <4주, 아급성 4~12주, 만성 ≥12주입니다. RARS는 연 ≥4회 급성 발작이며 발작 사이는 완전 무증상입니다.

객관 소견·수술 평가

비내시경에서 폴립·농성 점액·부종을 확인합니다. CT는 진단 확정·수술 계획·합병증 의심 때 사용합니다. Water's view는 정확도가 낮아 진단 검사로 권하지 않는다는 강의 슬라이드 및 연자 Q&A 설명입니다.

수술을 고려할 병변

약물치료 불응 CRS·폴립, 골침식/골염, 진균구(fungal ball), 배출구 폐쇄로 커지는 점액낭종(mucocele), 비중격만곡·하비갑개 비대가 대상입니다. 염증과 구조적 폐쇄는 공존할 수 있습니다. 수술 후에도 세척·INCS·정기 내시경 관리가 필요합니다.

권혁수 연자 Q&A · 우연한 낭종

매끈하고 둥근 상악동 바닥 음영은 흔한 점액저류낭종(mucous retention cyst)입니다(일반인 약 10%). 무증상이라면 치료·추적 촬영을 하지 않습니다. 커지거나 부비동을 거의 채우며 증상이 있으면 의뢰합니다. 뼈 파괴·팽창·불규칙 경계, 얼굴 부종·감각저하도 의뢰 소견입니다.